

Anlagenkonvolut zum Kurzprotokoll der 13. Sitzung des Ausschusses für Gesundheit am 15. Oktober 2025

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Ausschuss für Gesundheit

Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026 (Haushaltsgesetz 2026 – HG 2026)
(21/600)

Änderungsantrag 1

Deutscher Pflegerat

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
12	Kapitel 1502 Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung <u>Titel 684 08 - 314</u> Projekte und Maßnahmen des Deutschen Pflegerats (DPR) zur Stärkung der Berufsgruppe der Pflegekräfte 900 <u>Haushaltsvermerk</u> - Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. - Aus diesem Titel dürfen auch Personalausgaben für den Deutschen Pflegerat geleistet werden.	Kapitel 1502 Pflegevorsorge und sonstige soziale Sicherung <u>Titel 684 08 - 314</u> Projekte und Maßnahmen des Deutschen Pflegerats (DPR) zur Stärkung der Berufsgruppe der Pflegekräfte 1 800 <u>Haushaltsvermerk</u> - Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informationsmaterialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. - Aus diesem Titel dürfen auch Personalausgaben für den Deutschen Pflegerat geleistet werden.	+ 900	Die zusätzlichen Mittel sollen zur angemessenen finanziellen Ausstattung des Deutschen Pflegerats (DPR) bereitgestellt werden, damit dieser seine im aktuell im parlamentarischen Verfahren befindlichen Gesetz „Gesetz zur Befugnisenerweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege“ vorgesehene Rolle als maßgebliche Organisation der Pflegeberufe wahrnehmen kann. Nur so können die gesetzlichen Beteiligungsrechte nach dem Fünften und Elften Buch SGB sachgerecht umgesetzt und die erforderlichen personellen Strukturen aufgebaut werden.

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Änderungsantrag 2

Gesundheitliche Aufklärung und Prävention

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
17	Kapitel 1503 Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 531 01 - 314</u> Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung 24 421 Verpflichtungsermächtigung 22 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 10 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 7 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 5 000 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1513 Tit. 111 01 und 119 01. 2. Rückzahlungen wegen Nachrabattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti und Ähnlichem fließen den Ausgaben zu. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 4. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden. Erläuterungen:	Kapitel 1503 Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 531 01 - 314</u> Gesundheitliche Aufklärung der Bevölkerung 27 421 Verpflichtungsermächtigung 22 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 10 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 7 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 5 000 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: Kap. 1513 Tit. 111 01 und 119 01. 2. Rückzahlungen wegen Nachrabattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti und Ähnlichem fließen den Ausgaben zu. 3. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 4. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden. Erläuterungen:	+ 3 000 (+ 0) (+ 0) (+ 0) (+ 0)	Die Mittel sollen zur Stärkung der gesundheitlichen Aufklärung und Prävention eingesetzt werden. Dabei sollen insbesondere die Kürzungen in zentralen Bereichen wie der Organspende, der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie der Gesundheitsförderung im Alter – und weiteren wichtigen Präventionsfeldern – zurückgenommen werden. Ein besonderer Schwerpunkt muss zudem auf der Suizidprävention liegen. Der Deutsche Bundestag hat sich bereits für die Einführung eines Suizidpräventionsgesetzes ausgesprochen, weshalb Suizidprävention künftig eine zentrale Rolle in den Präventionsmaßnahmen des Bundesministeriums für Gesundheit einnehmen muss.
	Bezeichnung 1 000€	Bezeichnung 1 000€		

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
	1. Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 2 236 2. Aufklärung zur Organ- und Gewebespende 5 058 3. Motivationskampagne zur Blut- und Plasmaspende 246 4. Gesundes Alter 1 147 5. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 1 843 6. Erhöhung der Reichweiten 1 024 7. Infektionsschutz (Impfen, Hygiene, Krisenkommunikation) 5 078 8. Stärkung der Laienreanimation 387 9. Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität - Informations- und Beratungsangebot zum Schutz vor Konversionsbehandlungen 352 10. Klimawandel, Umwelt und Gesundheit 187 11. Nationaler Präventionsplan 1 764 12. Long-Covid Beratung 200 13. Diabetes mellitus und andere nicht übertragbare Krankheiten (NCD) 899 14. Begleitende Maßnahmen zur Krankenhausreform 4 000	1. Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 2 600 2. Aufklärung zur Organ- und Gewebespende 5 880 3. Motivationskampagne zur Blut- und Plasmaspende 286 4. Gesundes Alter 1 333 5. Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 2 143 6. Erhöhung der Reichweiten 1 190 7. Infektionsschutz (Impfen, Hygiene, Krisenkommunikation) 5 904 8. Stärkung der Laienreanimation 450 9. Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität - Informations- und Beratungsangebot zum Schutz vor Konversionsbehandlungen 409 10. Klimawandel, Umwelt und Gesundheit 217 11. Nationaler Präventionsplan 850 12. Long-Covid Beratung 200 13. Diabetes mellitus und andere nicht übertragbare Krankheiten (NCD) 1 045 14. Begleitende Maßnahmen zur Krankenhausreform 4 000 15. Suizidprävention 914		

Änderungsantrag 3

Drogen- und Suchtprävention

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
19	Kapitel 1503 Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 531 03 - 314</u> Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs 14 102 Verpflichtungsermächtigung 12 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 5 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 4 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 3 000 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Rückzahlungen wegen Nachrabbattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti und Ähnlichem fließen den Ausgaben zu. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 3. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden. <u>Erläuterungen:</u> 1. In Ausführung des Aktionsplanes Drogen und Sucht soll die Aufklärung durch massen- und personalkommunikative Maßnahmen zielgruppenorientiert fortgesetzt werden.	Kapitel 1503 Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 531 03 - 314</u> Aufklärungsmaßnahmen auf dem Gebiet des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs 19 102 Verpflichtungsermächtigung 12 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 5 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 4 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 3 000 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Rückzahlungen wegen Nachrabbattierungen, nachträglich eingeräumten Skonti und Ähnlichem fließen den Ausgaben zu. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 3. Aus den Mitteln dürfen auch Zuwendungen gemäß § 23 BHO gewährt werden. <u>Erläuterungen:</u> 1. In Ausführung des Aktionsplanes Drogen und Sucht soll die Aufklärung durch massen- und personalkommunikative Maßnahmen zielgruppenorientiert fortgesetzt werden.	+ 5 000 (+ 0) (+ 0) (+ 0) (+ 0)	Die zusätzlichen Mittel sollen zur Stärkung der Prävention im Bereich des Drogen- und Suchtmittelmissbrauchs eingesetzt werden, insbesondere zur Aufklärung über die Gefahren von Methamphetamin. Eine Anhebung des Ansatzes auf das Niveau von 2024 ist erforderlich, da der aktuelle Ansatz den tatsächlichen Bedarf nicht widerspiegelt.

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
	2. Die Mittel werden überwiegend dem Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit zur Bewirtschaftung zugewiesen.	2. Die Mittel werden überwiegend dem Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit zur Bewirtschaftung zugewiesen. 3. Insbesondere Aufklärungsmaßnahmen zum Missbrauch von Methamphetaminen ("Crystal Meth") sollen finanziell gestärkt werden.		

Änderungsantrag 4

Patientensicherheit

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
20	<u>Kapitel 1503</u> Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 684 02 - 314</u> Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der Patientensicherheit 4 000 Verpflichtungsermächtigung 2 400 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 1 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 900 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 500 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Personalausgaben geleistet werden.	<u>Kapitel 1503</u> Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 684 02 - 314</u> Projekte und Maßnahmen zur Stärkung der Patientensicherheit 4 500 Verpflichtungsermächtigung 2 400 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 1 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 900 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 500 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Personalausgaben geleistet werden.	+ 500 (+ 0) (+ 0) (+ 0) (+ 0)	Die zusätzlichen Mittel sollen für eine bundesweite Aufklärungskampagne zur Sepsisprävention eingesetzt werden. Ziel ist es, das Wissen über Frühsymptome, die Notwendigkeit der schnellen Behandlung sowie Präventionsmaßnahmen wie Impfungen, Hygieneregeln und die konsequente Behandlung von Infektionen zu stärken, um Sepsissterbefälle deutlich zu reduzieren.

Änderungsantrag 5

Nationales Gesundheitsportal

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
21	<u>Kapitel 1503</u> Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 686 01 - 314</u> Nationales Gesundheitsportal 1 850 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2027 bis zu 700 <u>Haushaltsvermerk</u> Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	<u>Kapitel 1503</u> Prävention und Gesundheitsverbände <u>Titel 686 01 - 314</u> Nationales Gesundheitsportal 1 950 Verpflichtungsermächtigung fällig im Haushaltsjahr 2027 bis zu 700 <u>Haushaltsvermerk</u> Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden.	+ 100 (+ 0) (+ 0) (+ 0)	Die zusätzlichen Mittel sollen bereitgestellt werden, um den Bundes-Klinikatlas weiterzuführen und seine Qualität zu verbessern. Eine finanzielle Schwächung des Projekts wäre aus Patient*innensicht ein fatales Signal, da Transparenz und Vergleichbarkeit in der Krankenhausversorgung gestärkt statt behindert werden müssen.

Änderungsantrag 6

Stärkung der internationalen Gesundheit

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
43	Kapitel 1505 Internationales Gesundheitswesen <u>Titel 686 01 - 314</u> Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit 55 880 Verpflichtungsermächtigung 30 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 15 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 10 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 5 000 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Informations-, therapeutisches und diagnostisches Material gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden kann, soweit dies für die Durchführung des Vorhabens notwendig ist. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Personalausgaben geleistet werden. <u>Erläuterungen:</u> 1. Die Haushaltsmittel sind bestimmt für die multilaterale Zusammenarbeit, an der Deutschland ein besonderes gesundheitspolitisches Interesse hat, wie die Förderung von Vorhaben internationaler Organisationen oder Initiativen, die Ausrichtung von oder die Beteiligung an internationalen Konferenzen und Workshops mit der Zielsetzung, die internationale öffentliche	Kapitel 1505 Internationales Gesundheitswesen <u>Titel 686 01 - 314</u> Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit 62 630 Verpflichtungsermächtigung 30 000 davon fällig: im Haushaltsjahr 2027 bis zu 15 000 im Haushaltsjahr 2028 bis zu 10 000 im Haushaltsjahr 2029 bis zu 5 000 <u>Haushaltsvermerk</u> 1. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen, Informations-, therapeutisches und diagnostisches Material gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegeben werden kann, soweit dies für die Durchführung des Vorhabens notwendig ist. 2. Aus diesem Titel dürfen auch Personalausgaben geleistet werden. <u>Erläuterungen:</u> 1. Die Haushaltsmittel sind bestimmt für die multilaterale Zusammenarbeit, an der Deutschland ein besonderes gesundheitspolitisches Interesse hat, wie die Förderung von Vorhaben internationaler Organisationen oder Initiativen, die Ausrichtung von oder die Beteiligung an internationalen Konferenzen und Workshops mit der Zielsetzung, die internationale öffentliche	+ 6 750 (+ 0) (+ 0) (+ 0) (+ 0)	Die zusätzlichen Mittel sollen eingesetzt werden, um die Kürzung im Titel zur Stärkung der internationalen öffentlichen Gesundheit von rund 3,5 Millionen Euro zurückzunehmen und gleichzeitig durch weitere Mittel die internationale Gesundheit zu stärken. Dadurch kann Deutschlands Verantwortung auf globaler Ebene gestärkt und den negativen Folgen des teilweisen Rückzugs anderer Länder aus der WHO-Finanzierung entgegengewirkt werden. Davon profitieren auch wichtige internationale Gesundheitsinitiativen wie die WHO und UNAIDS, die maßgeblich zur globalen Gesundheitsvorsorge und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beitragen.

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
	Gesundheit zu stärken. Hier liegt der Fokus insbesondere auf der WHO als die für internationale öffentliche Gesundheit zuständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen (VN). Weiterhin dienen die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Finanzierung von spezialisierten Maßnahmen der internationalen Gesundheitssicherheit. Hierfür wird Schlüsselexpertise aus Deutschland, insbesondere aus den Fachinstitutionen des BMG genutzt, die zugleich für die jeweiligen Themen auch national zuständig sind. Diese Expertise stellt ein Alleinstellungsmerkmal dar, welches in dieser Form nur im BMG mit seinem Geschäftsbereich vorhanden ist. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt vor allem auf der Vorbeugung, frühzeitige Erkennung und Eindämmung des Ausbruchs und der Verhinderung der grenzüberschreitenden Ausbreitung von Infektionskrankheiten, einschließlich solcher mit antimikrobiellen Resistenzen. Zur Erreichung der genannten Zwecke kann eine Zusammenarbeit mit ausländischen Stellen, insbesondere Public Health Institutionen im globalen Süden erfolgen, um deren Fähigkeiten zur eigenständigen Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen zu stärken. Die Zusammenarbeit kann auch eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Einrichtungen in Partnerstaaten, die Ausbildung von Personal der Partnerstaaten sowie Unterstützungsleistungen im Bereich der epidemiologischen Lage- und Risikobewertung und des Krisenmanagements umfassen.	Gesundheit zu stärken. Hier liegt der Fokus insbesondere auf der WHO als die für internationale öffentliche Gesundheit zuständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen (VN). Weiterhin dienen die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Finanzierung von spezialisierten Maßnahmen der internationalen Gesundheitssicherheit. Hierfür wird Schlüsselexpertise aus Deutschland, insbesondere aus den Fachinstitutionen des BMG genutzt, die zugleich für die jeweiligen Themen auch national zuständig sind. Diese Expertise stellt ein Alleinstellungsmerkmal dar, welches in dieser Form nur im BMG mit seinem Geschäftsbereich vorhanden ist. Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt vor allem auf der Vorbeugung, frühzeitige Erkennung und Eindämmung des Ausbruchs und der Verhinderung der grenzüberschreitenden Ausbreitung von Infektionskrankheiten, einschließlich solcher mit antimikrobiellen Resistenzen. Zur Erreichung der genannten Zwecke kann eine Zusammenarbeit mit ausländischen Stellen, insbesondere Public Health Institutionen im globalen Süden erfolgen, um deren Fähigkeiten zur eigenständigen Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen zu stärken. Die Zusammenarbeit kann auch eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Einrichtungen in Partnerstaaten, die Ausbildung von Personal der Partnerstaaten sowie Unterstützungsleistungen im Bereich der epidemiologischen Lage- und Risikobewertung und des Krisenmanagements umfassen.		
	2. Aus diesem Titel dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.	2. Aus diesem Titel dürfen auch sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden.		
	3. Für UNAIDS werden aus diesem Titel Mittel in Höhe von 6 750 T€ bereitgestellt.	3. Für UNAIDS werden aus diesem Titel Mittel in Höhe von 10 000 T€ bereitgestellt.		

Änderungsantrag 7

Beiträge an internationale Organisationen

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
44	<u>Kapitel 1505</u> Internationales Gesundheitswesen <u>Titel 687 01 - 314</u> Beiträge an internationale Organisationen 39 334	<u>Kapitel 1505</u> Internationales Gesundheitswesen <u>Titel 687 01 - 314</u> Beiträge an internationale Organisationen 49 334	+ 10 000	Die zusätzlichen Mittel sollen eingesetzt werden, um Deutschlands internationale Verantwortung im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu übernehmen und ein deutliches Signal zu setzen. Sie dienen der Förderung multilateraler Zusammenarbeit, etwa durch Vorhaben internationaler Organisationen, Beteiligung an Konferenzen und Workshops, und stärken gezielt die WHO als zuständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Eine Erhöhung der deutschen Pflichtbeiträge würde zudem andere Länder in die Verantwortung ziehen und den internationalen Organisationen maximalen Nutzen bringen.

Änderungsantrag 8

Geschäftsbereich BIÖG

Seite des Reg.- Entwurfs 2026	Entwurf Ansätze in 1.000 €	Änderungsantrag Ansätze in 1.000 €	Ansatz mehr(+) weniger(-) in 1.000 €	Begründung/ Bemerkung
1	2	3	4	5
71	Kapitel 1513 Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit <u>Titel 511 01 - 314</u> Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 1 671	Kapitel 1513 Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit <u>Titel 511 01 - 314</u> Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software, Wartung 3 671	+ 2 000	Die zusätzlichen Mittel sollen eingesetzt werden, um das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) angemessen auszustatten und seine vielfältigen Aufgaben in gesundheitlicher Aufklärung, Prävention, Gesundheitsförderung und Infektionsschutz wirksam wahrnehmen zu können. Prävention ist ein zentraler Baustein einer zukunftsfähigen Gesundheitspolitik und muss stärker als bisher in den Fokus rücken. Mit dem neu geschaffenen Institut besteht die Chance, die Präventionsarbeit in Deutschland strategisch zu bündeln, wissenschaftlich zu fundieren und sichtbarer zu machen. Es darf nicht dabei bleiben, dass die bisherige Arbeit der BZgA lediglich unter neuem Namen fortgeführt wird – das BIÖG muss vielmehr zu einer modernen, leistungsfähigen Einrichtung weiterentwickelt werden, die neue Impulse für eine umfassende und wirksame Gesundheitsförderung setzt und zugleich aktuelle Aufgaben, wie begleitende Maßnahmen zur Krankenhausreform, gezielt unterstützt.



Betrifft:

Stellungnahme von Dr. Daniel Vilser für den Ärzte und Ärztinnenverband Long Covid zum Fachgespräch "Postvirale Erkrankungen wie Long-Covid und ME/CFS: Fortschritte in der Forschung und Versorgung – Aktuelle Herausforderungen und politische Handlungsoptionen"

Ausschuss für Gesundheit in seiner Sitzung am Mittwoch, den 15. Oktober 2025

Sehr geehrte Mitglieder des Gesundheitsausschusses,

postakute Infektionserkrankungen (PAIS), zu denen Long-Covid und ME/CFS zählen, sind klinisch relevante, oft fluktuierende, infektionsassoziierte Langzeiterkrankungen mit erheblicher Alltags- und Teilhabebeeinträchtigung. 3–6% aller mit SARS-CoV-2 infizierten Erwachsenen haben über die akute Infektion hinaus mit Problemen zu kämpfen. Kinder und Jugendliche sind etwas seltener betroffen.

Neben dem persönlichen Leid der Betroffenen ist die finanzielle Belastung der Gesellschaft enorm. Die jährlichen Gesamtkosten, unter anderem aus Produktivitätsverlusten, Arbeitgeber- sowie Gesundheitsausgaben, betrugen 2024 geschätzte 63,1 Milliarden Euro.

Die Schwierigkeit in der Diagnostik besteht darin, dass PAIS kein einheitliches Krankheitsbild ist, sondern verschiedene Pathomechanismen zu dem desaströsen Zustand der Patienten führen können. Auch wenn die Forschung in den letzten Jahren bereits erhebliche Fortschritte bei der Identifizierung dieser Vorgänge gemacht hat, existiert derzeit weder ein einzelner Biomarker noch ein spezifischer Test, der die Diagnose PAIS oder ME/CFS zweifelsfrei sichern kann.

Therapeutisch sind kausale medikamentöse Verfahren bislang nicht gesichert, allerdings haben wir Fortschritte bei der Behandlung einzelner Symptome gemacht.

Was braucht es von der Politik:

Flächendeckende, verlässlich finanzierte interdisziplinäre Versorgungsstrukturen – inklusive pädiatrischer Angebote – mit klaren Überweisungspfaden, PEM-sensiblen Reha-Konzepten und arbeitsmedizinischer Reintegration. Ein Beispiel dafür könnte das Projekt Pednet sein, welches für Kinder und Jugendliche ein solches Versorgungsnetzwerk geschaffen hat und die Basis für weitere Forschung liefert. Essenziell ist, dass solche Strukturen, die mit erheblichem Aufwand etabliert wurden, auch weiter finanziert werden. Während die Betreuung der Erkrankten in die perspektivisch in die Regelversorgung übergehen sollte bleibt die Finanzierung der so wichtigen begleitenden Forschung Aufgabe der Bundesregierung und spezieller Fördervorhaben.

Eine mehrjährige Forschungs- und Innovationsoffensive (biomedizinische Mechanismen, stratifizierende Endotypen, Register/Kohorten, Biobanken) und verbindliche randomisierte, qualitätsgesicherte Therapiestudien. Ein besonderer Fokus ist hierbei auf Kinder und Jugendliche zu legen, weil Kinderärzte aktuell fast ausschließlich im „Off-Label“-Bereich agieren.

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

Sozial- und arbeitsrechtliche Klarheit herstellen (leistungsrechtliche Zugänge, Stufen-Wiedereingliederung, Nachteilsausgleich, Homeoffice, alternative Schulkonzepte).

Eine bundesweite, zielgruppenspezifische Aufklärungsoffensive, die unsichtbare Krankheitsverläufe sichtbar macht, Fehlwahrnehmungen korrigiert und Stigmatisierung abbaut. Weil Long-Covid und ME/CFS Erkrankte häufig keine äußerlich erkennbaren Anzeichen zeigen, werden Betroffene noch zu oft missverstanden, bagatellisiert oder benachteiligt – dem ist durch klare, evidenzbasierte Information und praxisnahe Handreichungen für Schulen, Betriebe und Verwaltungen entgegenzuwirken.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Daniel Vilser
Vizepräsident ÄLC
Chefarzt
Kinderkliniken Ingolstadt/Neuburg
AMEOS Klinikum St. Elisabeth Neuburg

Literatur:

BFARM, Therapiekompas abgerufen am 9.10. unter [BfArM - Expertengruppe Long COVID Off-Label-Use](#)

Daniell, J.....The rising cost of Long COVID and ME/CFS in Germany Mai2025 abgerufen am 9.10.2025 unter [The-rising-cost-of-Long-COVID-and-MECFS-in-Germany.pdf](#)

Koczulla, A. R.... S1-Leitlinie post-COVID/long-COVID. 30.05.2024 abgerufen 9.10.2025 unter: [020-027p1_S1_Post_COVID_Long_COVID_2025-08-verlaengert.pdf](#)

Schmidt, J., Töpfner, N., Vilser, D., Storm van's Gravesande, K., Oftring, Z., Soler Wenglein, J., ... & Behrends, U. (2025). Postakute Infektions-und Vakzinierungssyndrome bei Kindern und Jugendlichen. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 1-7.



15. Oktober 2025

Stellungnahme zum Fachgespräch: „Postvirale Erkrankungen wie Long-Covid und ME/CFS: Fortschritte in der Forschung und Versorgung – Aktuelle Herausforderungen und politische Handlungsoptionen“

Deutscher Bundestag, Ausschuss für Gesundheit, 15.10.2025 um 09:30 Uhr

Mündliche Stellungnahme

Sehr geehrte Abgeordnete,
 sehr geehrte Sachverständige,

ich bedanke mich herzlich für die Einladung und gehe kurz auf einige Aspekte ein, die aus Sicht von Menschen, die mit Long COVID und ME/CFS leben, besonders hervorzuheben sind.

Unverändert bestehen Barrieren, die einer flächendeckenden medizinischen und sozialen Versorgung im Wege stehen. Hausarztpraxen sind in der Regel nicht für die ausführliche Diagnostik bei diesen komplexen Krankheiten ausgestattet. Der diagnostische und therapeutische Aufwand wird unzureichend über die aktuellen EbM-Ziffern abgedeckt. Die allgemeine kassenärztliche Versorgung, wie vom G-BA vorgesehen, funktioniert oft nicht. Vielen Versorgenden fehlt es schlicht an Wissen über die Erkrankungen. Aufgrund mangelnder Erfahrungen verschreiben viele Hausärztinnen so auch keine Off-Label-Medikamente. Ein möglicher Lösungsansatz wäre die Etablierung von Kompetenzzentren bzw. Schwerpunktpraxen, so wie diese in Rheinland-Pfalz initiiert wurden. Sowie die Etablierung von strukturierten und standardisierten Behandlungsprogrammen.

Besonders gravierend ist die Lage für Menschen mit schwerer Krankheit, die in der Regel keinerlei Zugang zu medizinischer Versorgung haben, weder im Klinik- noch im Praxissetting. Neupatientinnen müssen mit langen Wartezeiten rechnen. Die Versorgung mit Hilfsmitteln und die Anerkennung von Pflegebedürftigkeit, notwendiger Assistenz oder Schwerbehinderung ist in der Regel erst durch Widerspruch oder Klage zu erreichen.

Frühzeitige Diagnostik und symptomorientierte Behandlung könnten möglicherweise bei vielen Betroffenen ein schweres Erkrankungsstadium mit vollständiger Erwerbsunfähigkeit verhindern. Reha-Maßnahmen können bei den meisten Patient*innen im bestmöglichen Fall maximal zu einem besseren

Krankheitsmanagement verhelfen, heilen jedoch nicht die zugrundeliegenden Krankheitsmechanismen. Die medikamentöse Therapie muss daher zum zentralen Baustein der Versorgung werden. In diesem Kontext sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Empfehlungen der Expertinnengruppe Long COVID Off-Label-Use in die flächendeckende Umsetzung zu bringen.

Aus Sicht der Betroffenen ist die Medikamentenforschung – im Off-Label-Bereich sowie an neuen Präparaten – das erfolgversprechendste Mittel zur Bekämpfung von Long COVID und ME/CFS. Wir fordern daher die Einrichtung einer Koordinationsstelle für Therapievorhaben in Deutschland, Förderrichtlinien für klinische Therapiestudien mit begleitender Biomarkerforschung, sowie die langfristige und angemessene Förderung von zentralen Therapieplattformen wie der Nationalen Klinischen Studiengruppe und dem Netzwerk Universitätsmedizin. Seitens der Politik sollten zudem Anreize geschaffen werden, damit es zeitnah zu einer Beteiligung der pharmazeutischen Industrie an der Therapieforschung kommt. Ein vom BMG- und BMFTR-initiiertes Pharma-Roundtable zu Long COVID und ME/CFS könnte hierfür eine mögliche Maßnahme sein.

Schätzungsweise leben in Deutschland rund 1,5 Mio. Menschen mit Long COVID oder ME/CFS. Beide Erkrankungen verursachten im Jahr 2024 geschätzte Kosten in Höhe von 63 Mrd. Euro. Demgegenüber stehen Investitionen der Bundesregierung in die Therapie, Biomarker, - und Diagnostikforschung in Höhe von ca. 15 Mio. € jährlich. Gerade auch aufgrund der geschilderten Erfahrungen der Betroffenen plädieren wir daher eindringlich für eine deutliche Aufstockung der Fördermittel für die Grundlagen- und Therapieforschung.

Vielen Dank.

Fachgespräch „Postvirale Erkrankungen wie Long-Covid und ME/CFS: Fortschritte in der Forschung und Versorgung Aktuelle Herausforderungen und politische Handlungsoptionen“

PD Dr. Dr. Bettina Hohberger

@Dr_B_Hohberger

Anlage 4	Deutscher Bundestag Ausschuss f. Gesundheit
	Ausschussdrucksache 21(14)29 gel. SV zur 13. Sitzung am 15.10.2025 - TOP 8 14.10.2025

Im Ausschuss für Gesundheit
am Mittwoch, den 15. Oktober 2025
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3 101



Friedrich-Alexander-Universität
Medizinische Fakultät

Dem Ausschuss ist das vorliegende Dokument
in nicht barrierefreier Form zugeleitet worden.

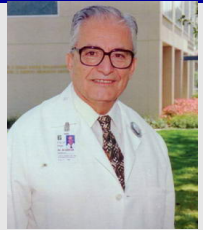
Augenklinik, Direktor: Prof. F.E. Kruse
Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen

**Uniklinikum
Erlangen**



Diabetes

Ein Beispiel für einen Siegeszug in der Medizin



Samuel Rahbar

„Zufalls“-Befund

Bestätigung des „Zufalls“-Befundes

Aufbau des Biomarkers & Diagnostikums

Verifizierung des Biomarkers unter Therapie

Clin. Chim. Acta, 22 (1968) 296–298

An abnormal hemoglobin in red cells of diabetics

In a survey carried out on 1200 patients from Tehran University Hospitals, in addition to three rare hemoglobins which are under investigation both in our department here and at the University of Cambridge, two patients also showed an abnormal fast moving hemoglobin fraction; both were suffering from diabetes mellitus.

Verifizierung in 47 weiteren Blutproben von Diabetikern

Aufbau/Optimierung der Labormethode zur optimalen Bestimmung der **neuen Bande (HbA1c)**

Bestätigung der Befunde mit der neuen Labormethode in einem anderen Labor

Correlation of Glucose Regulation and Hemoglobin A_{1c} in Diabetes Mellitus

We studied the increased levels of hemoglobins A_{1a+1b} and A_{1c} in five hospitalized diabetic patients to determine whether changes in diabetic control would cause parallel changes in the levels of these hemoglobins. Before control of diabetes the mean fasting blood sugar for all patients was 343 mg per deciliter (range, 280 to 450), and hemoglobin A_{1c} concentration 9.8 per cent (range, 6.8 to 12.1). During optimal diabetic control the blood sugar concentration was 84 mg per deciliter (range, 70 to 100), and hemoglobin A_{1c} concentration 5.8 per cent (range, 4.2 to 7.6). Hemoglobin A_{1c} concentration appears to reflect the mean blood sugar concentration best over previous weeks to months. The periodic monitoring of hemoglobin A_{1c} levels provides a useful way of documenting the degree of control of glucose metabolism in diabetic patients and provides a means whereby the relation of carbohydrate control to the development of sequelae can be assessed. (N Engl J Med 295:417–420, 1976)

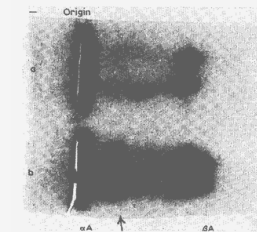


Fig. 4. Starch gel electrophoresis of PCMB-treated hemoglobins. a: normal; b: diabetic. Note the existence of an additional band faster than αA ($\uparrow$).

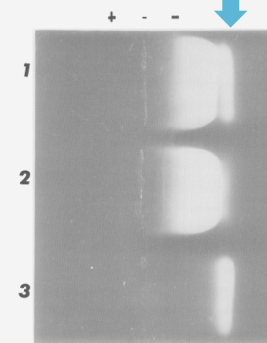


Fig. 1
Agar gel electrophoresis, pH 6.2, 0.05M citrate buffer. (1) Hemolysate from diabetic. (2) Hemolysate from normal. (3) Purified Hb A_{1c}.

Post-COVID Syndrom & ME/CFS

Der Beginn eines Siegeszuges in der Medizin

„Zufalls“-Befund



Viele Biomarker-Kandidaten für Post-COVID Syndrom (PCS) & ME/CFS



Bestätigung des „Zufalls“-Befundes



Biomarker-Kandidaten für Untergruppen der Patienten mit PCS / ME/CFS

Aufbau des Biomarkers & Diagnostikums

BMBF/BMG geförderten Forschungsvorhaben (aktuell laufend):

u.a.

- Aufbau von spezifischen Biomarkern & Biosignaturen für PCS & ME/CFS-Subgruppen
- Aufbau von Diagnostika



Verifizierung des Biomarkers unter Therapie

BMBF/BMG geförderte Forschungsvorhaben (*Bedarf*):

u.a.

- *Validierung der spezifischen Biomarker & Biosignaturen für die PCS & ME/CFS-Subgruppen innerhalb Therapiestudien*



**Spezifische Therapien für spezifische Untergruppen von PCS & ME/CFS
(diagnostiziert anhand der Biomarker/Biosignaturen)**

